

Información Paciente

Nombre : Alfredo Ruiz Collante
Edad : 79a 10m 22d
Dirección : 3 Longavi Parcela 71

Rut : 4.802.280-4
Fecha Nacto: 03/07/1942
Comuna : Longavi

N° Archivo : 2210145
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 9853 4730

N° Epicrisis
300303

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Ingreso : 25/02/2022 02:12

Días Estadía : 89

Unidad de Egreso : Utim

Fecha Egreso : 25/05/2022 17:05

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS UTIM 6/4- 25/05/22

NOMBRE: Alfredo Eugenio Ruiz Collante

RUT: 4802280-4

EDAD: 79 años

FI SU CASR: 25/02/2022

FI UTIM: 26/02/2022

FI UPC: 02/03/2022

FRI UTIM: 8/03/2022 FI Modular: 16/03/2022

FI SALA: 26/03/2022

FRI UTIM: 27/03/2022

FI HC: 31/03/2022

FI UTIM: 03/05/2022

FI HC: 11/05/2022

ANTECEDENTES

· Médicos: HTA, DMNIR, HPB, Asma, Obs.Insuficiencia venosa EEII

· Quirúrgicos: (-)

· Fármacos: No refiere

· Alergias: (-)

· Hábitos: TBQ (-), OH (-), Drogas (-)

· Hospitalizaciones recientes:

· Sociales:

· Inmunizaciones (influenza, neumococo, covid): Hábitos:Inmunizaciones: sin vacunas (médico particular le habría dicho que estaba contraindicado por insuficiencia venosa)

ANAMNESIS PRÓXIMA

Paciente con cuadro de 15 días de evolución (FIS aprox 10/02) caracterizado por CEG, disnea progresiva asociada a tos con expectoración. Es derivado desde SAMU a SU HSR, se describe al ingreso vigil, orientado T-E, hipertenso (190/90), normocárdico, afebril, con requerimientos de oxígeno por naricera a 4 litros para sat 98 %, bien perfundido, con buena mecánica ventilatoria y crépitos en ambas bases pulmonares.

Ex ingreso SU: 25/02/22: Hcto/Hb: 39.9/13.2, GB: 4220, Plaq: 109000, PCR: 169.2; GSV: pH: 7.37, CO2: 41.1, BIC: 23.5, BE: -1.7, Lact: 1.8 mmol/L; BUN/Crea: 32.1/1.59, ELP: 133/4.36/101, Ca: 8.8, Mg: 2.1, BT/BD: 1.5/0.77, GOT/GPT: 77/60, GGT/FA:

Fecha Epicrisis : 25/05/2022 17:28

Fecha Última Actualización: 25-05-2022 17:28:27

Página 2 de 3

48/61, INR: 1.35. TTPK: 47.5, PCR SARS COV 2 (+). Rx de tórax: Infiltrado bilateral multilobar, posible foco consolidativo a nivel parahiliar derecho. Posible atelectasia de lóbulo superior. ECG: ritmo sinusal, bloqueo completo de rama derecha.

Se hospitaliza en sala de medicina para manejo (25/02/22). Se inicia protocolo Recovery. Evoluciona en malas condiciones, con aumento de requerimientos de oxígeno hasta CNAF, llegando a requerir hasta 60 L, FiO2 70%. Inicialmente se había planteado manejo proporcional, dado mala red de apoyo, sin embargo al analizar caso, considerando paciente autovalente, sin fallas de otros sistemas, sin desnutrición, se decide manejo activo en conjunto con paciente, por lo que se decide traslado a Intermedio el mismo 25/02/22. Al ingreso a UTIM se inicia Ceftriaxona empírica por parámetros inflamatorios elevados. Evoluciona con mala mecánica ventilatoria, progresión de conflicto de intercambio GSA de control el 1/03/22 con PaFi 110, mala respuesta a CNAF, por lo que se decide VMI. Se premedica con fentanyl 300 ug, lidocaína 50 mg, se induce con etomidato 30 mg y se administran 150 mg de rocuronio. Al 2do intento se logra IOT exitosa con tubo 8.5, se traslada a UPC para continuar manejo.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

1. Hemodinamia: HDN: Al ingreso a UPC soporte con DVA NAD en dosis bajas en relación a sedoanalgesia y tendencia a la hipotensión. Posteriormente fue extubado con suspensión de DVA el día 10/03/2022. Luego de su salida de UTIM es trasladado al Hospital modular donde se mantenía HDN estable sin necesidad de momento de reinicio de VDO. Se evalúa con Ecocardio TT el día 12/04/2022 que muestra AI levemente dilatada. Luego se inicia IECA a dosis bajas con buena respuesta.

2. Respiratorio: Ingresa en contexto de NAC por SARS COV2. Inicialmente grave con requerimiento de IOT y posterior VMI entre el 01/03-05/03. En este contexto completa 10 días de protocolo Recovery. En su evolución se realiza AngioTAC que muestra TEP agudo segmentario lingular iniciándose anticoagulación. Luego en su primer traslado a UTIM (08/03) evolución con cuadro séptico nuevo ingresando con regular mecánica y con tendencia a la obstrucción. En este contexto se decide manejo con CNAF y NBZ con Berodual titulando la terapia a la baja. Luego se traslada al Hospital Modular donde se logra la suspensión del O2 el día 19/03. El 23/03 presenta alza de parámetros inflamatorios asociado a requerimientos de O2 aumentados requiriendo apoyo con Venturi se controla con TAC de Tórax el día 26/03 que muestra nuevo Foco de condensación en LSD, debido a requerimientos de O2 se realiza traslado a UTIM con nuevo requerimiento de CNAF desde el 27/03 al 30/03, logra paso a naricera sin embargo con destete prolongado fluctuante entre 0.5-2 Lt de O2. Se realiza IC a broncopulmonar donde se decide prueba terapéutica con corticoides planteando posible Neumonía organizante. Inicia (07/04) pulsos de Dexametasona 20 mg al día por 5 días con posterior traslape a 50 mg al día. Presenta nueva descompensación el día 29/04 con alza de requerimientos de O2 asociado a descarga séptica en TAC de Tórax se observa aumento del componente de vidrio esmerilado de los focos de condensación del estudio previo ampliando cobertura ATB. Se conecta nuevamente a CNAF manteniéndose estacionario. Evaluado nuevamente por Broncopulmonar se decide FBC y LBA el día 04/05 el que resulta frustrado dado que paciente desatura además de negar voluntad de VMI por lo que se difiere procedimiento. Presenta evaluación por Fonoaudiología y Otorrino que determina la presencia de parálisis de cuerda vocal sospechando descompensaciones debidas a episodios recurrentes de aspiración. Evoluciona estacionario hasta el día 18/05 donde presenta episodio de desaturación durante la madrugada asociado a incremento en los requerimientos de O2 suplementarios asociados a la retención de CO2 en gases arteriales, probablemente determinado por la presencia de nuevos episodios de microaspiración.

Evaluado por equipo ORL quienes determinan parálisis cordal ante mala respuesta a rehabilitación FNA, se define GTT.

Ante nuevo deterioro clínico, se traslada a UTIM el 18/05/22, se inicia manejo con Imipenem/ Vancomicina, que se ajusta Linezolid por portación ERV previa el 23/05. Evoluciona tórpidamente con aumento de requerimientos O2 suplementario, CNAF 60/90%. Paciente rechaza SNG, con autoretiro en múltiples oportunidades. Por deterioro clínico, se inicia manejo sintomático de disnea con Morfina. Presenta PCR Hipóxico el 25/05/22 a las 15:55 hrs.

3. Infeccioso: Múltiples Hits infecciosos sin microorganismos aislados

a. 08/03 febril, se pancultiva sin MO aislada, completa 7 días de Imipenem y Vancomicina.

b. 23/03 quiebre clínico respiratorio, es tratado con Imipenem + Vancomicina, ajustado a Imi-Line-Amika por deterioro clínico y portación de Enterococo Van B, completa 7 días Imipenem y 5 días Amikacina.

c. 17/04 Aumento PCR, se pancultiva, panel viral, negativo. Luego disminuye espontáneamente hasta PCR 30, sin leucocitosis 29/04.

d. 29/04 Febril, taquicárdico, con mayor requerimientos de oxígeno suplementario, se pancultiva y se inicia Imipenem empírico. A la fecha estudio microbiológico: 29/04 HMC (p). EO no inflamatorio, UC polimicrobiano. Tendencia de PI a la baja PCR 135->48. Completa 7 días de Imipenem el día 06/05 con PPII a la baja, afebril. No se logra cultivo de expectoración porque paciente no expectora.

e. 17/05 con PCR 53, panel viral negativo, TAC de control 17/05 con progresión de lesiones, SO no inflamatorio y UC pendiente aún. Sin embargo se decide escalar a Imipenem además de inicio de corticoides en dosis de estrés.

f. 23/05 portación ERV VanB previa se suspende Vancomicina y se inicia Linezolid. Sin embargo, mala respuesta mantiene altos requerimientos de O2 por CNAF; alza de PPII, sin posibilidad de estudio microbiológico.

Fecha Epicrisis : 25/05/2022 17:28

Página 2 de 3

Fecha Última Actualización: 25-05-2022 17:28:27

Página 3 de 3

2. Nefrológico: Elevación de creatinina hasta 1.59, sin basal conocido. Evoluciona con AKI KDIGO III interpretada como Mixta dado antecedente de HPB y requerimientos de Sonda Foley además de buena respuesta a volemicación. Es evaluado por Urología, se indica Tamsulosina 0.4 mg a permanencia y retiro de Sonda Foley, evolucionando sin conflicto posterior a retiro, presenta diuresis espontánea, con buena función renal. En contexto de nueva interurrencia séptica, presenta deterioro de función renal, oligoanurico.

3. ETE: TEP COVID 02/03 en anticoagulación con HBPM, previamente se había iniciado anticoagulación con acenocumarol, sin embargo posteriormente por inestabilidad clínica se decide retorno a HBPM.

Manejo Hasta UTIM NO IOT, NO RCP
HORA DEFUNCION: 15:55 hrs

DX DEFUNCION:

1. Insuficiencia Respiratoria Aguda:

1. Neumonía Aspirativa

a. Neumonía persistente post COVID-19, complicada con signos de organización

2. Paciente crítico crónico

b. Miopatía de paciente crítico

c. Parálisis cordal derecha post IOT (NF 12/04 ORL: disfonía)

2. TEP submasivo: Segmentario lingular en anticoagulación

3. AKI KDIGO III multifactorial

4. Rinosinusitis unilateral derecha tratada

5. Antecedentes: Caso social (vive con AM dependiente severa), DMNIR, HTA, Asma, HPB, Insuficiencia venosa EEII

Diagnóstico de Egreso

EMBOLIA PULMONAR -
COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO -
CONDICIÓN DE SALUD POSTERIOR A COVID-19 -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

fallecido

Plan Post Alta

traslado a anatomía patológica

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Hiposódico

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Manuel Valera Arrieche
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 25/05/2022 17:28

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:43

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar